

a8_escalation_decision 测试报告

生成时间：2026-05-18 15:01:19

测试时间：2026-05-18 15:01:19

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1093 markers=10

禁用工具 success=True chars=794 markers=12

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_风险照护联动:tool_风险照护联动：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

《BPSD 事件处理建议》

长者姓名：陈萍忠

事件发生时间：返院第3天上午10:00

评估日期：当前

一、处置等级

低（轻度BPSD事件）

本次事件表现为沉默、拒绝沟通、不配合康复训练，**无过激行为、无自伤/伤人风险、无情绪激越**，且事件后情绪已平稳，生命体征正常。结合NPI评分16分（较住院前明显改善），符合轻度BPSD行为特征，属认知障碍患者常见的被动抵抗行为，不构成紧急风险。

二、继续观察条件

在满足以下全部条件的前提下，可维持常规照护并继续观察：

1. BPSD症状未出现新发或加重（如躁动、攻击、幻觉、游走等）；
2. 生命体征持续平稳（心率 ≥ 50 次/分，无头晕、胸闷、乏力等主诉）；

3. 日常规律服药依从性良好，无漏服或拒药；
4. 未发生新增跌倒、皮肤破损、急性胃肠道症状（呕吐/腹泻/发热）等异常事件。

三、护士介入条件

****不满足**。**

当前无生命体征异常、无急性躯体不适、无行为失控或安全风险，无需护士专项介入。

四、GP介入条件

****不满足**。**

BPSD症状处于改善期，无证据显示症状复发或由潜在躯体疾病（如感染、疼痛、代谢紊乱）诱发，暂无需全科医生（GP）评估或药物方案调整。

五、后续观察重点

1. ****BPSD行为依从性****：关注非药物干预（如康复、认知训练）的接受度，避免强制参与引发抵触。可尝试更灵活、个体化的活动形式（如短时、小组、音乐引导）。
2. ****皮肤完整性****：鉴于历史多次无明确诱因的皮肤擦伤与淤青（高风险项），需每日检查皮肤状况，排查环境安全隐患（如家具边角、扶手锐利处），并考虑安排凝血功能筛查。
3. ****循环功能监测****：心率持续处于正常下限（60次/分），结合心脏起搏器植入史，建议增加日间多时段心率、血压监测（尤其活动后），评估心血管稳定性。
4. ****家属沟通与支持****：主动向子女说明老人当前BPSD改善趋势及本次事件性质，提供照护策略指导，缓解其焦虑情绪，鼓励正向互动。

六、升级流程是否触发

****否**。**

本次事件未达到护士或GP介入阈值，无需启动风险升级流程。维持现有照护计划，加强观察与家属沟通即可。

****备注****：本建议基于最新事件报告为核心依据，历史风险数据仅作参考。若未来24-48小时内出现行为恶化、躯体不适或新发异常，请立即重新评估并考虑升级处置。

【禁用工具输出摘录】

****《BPSD 事件处理建议》****

****处置等级****：轻度

****继续观察条件****：

- 老人当前情绪平稳，生命体征正常；

- BPSD症状较住院前明显改善（NPI评分16分）；
- 拒绝行为局限于康复训练场景，无泛化至日常生活或其他照护环节；
- 无攻击、自伤、激越、妄想等高风险行为；
- 日常服药依从性良好，基础疾病控制稳定。

****护士介入条件**：**

（留空）——当前无生命体征异常、无急性躯体不适、无行为失控或安全事件，不符合护士紧急介入指征。

****GP介入条件**：**

（留空）——无BPSD症状恶化证据，无新发躯体症状，当前用药方案稳定且有效，无需医生紧急评估或药物调整。

****后续观察重点**：**

1. ****情绪与行为变化****：关注是否出现烦躁、言语攻击、夜间躁动、幻觉或妄想等BP
SD复发征兆；
2. ****康复参与意愿****：尝试调整康复形式（如改为小组活动、音乐引导、家属陪伴参与），观察接受度变化；
3. ****环境适应性****：返院初期可能存在适应压力，需评估环境刺激是否过载，适当提供安静过渡空间；
4. ****家属沟通与支持****：及时向子女反馈老人整体改善趋势，解释当前拒绝行为属常见适应反应，缓解其焦虑，避免家属过度干预反增老人压力；
5. ****服药依从性与副作用****：持续监测当前精神类或心血管药物是否产生迟发性副作用（如嗜睡、锥体外系反应）。

****升级流程是否触发**：否**

****综合建议**：**

本次事件属轻度、情境性BPSD表现，与返院适应期相关，整体风险低。建议维持现有照护计划，强化非药物干预（如情感支持、兴趣引导、结构化日程），加强家属沟通以协同照护。若未来24-48小时内出现情绪激越、拒绝进食/服药、睡眠紊乱加剧或生命体征波动，则需重新评估并考虑启动护士或GP介入流程。